

LAUDO PSICOLÓGICO AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

1. Identificação

1.1. Identificação do Laudo

Autor (a): Helen Taizy Lira de Mendonça (CRP 02/28219)

Solicitante: Dr. Carlos Lacerda – Psiquiatra (CREMEB 23833 / CREMEPE 21569)

Finalidade: Avaliação neuropsicológica solicitada para investigação de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH).

1.2. Identificação do Paciente

Nome: Gabrielly dos Santos Rocha

Sexo: Feminino

Data de nascimento: 25/09/2002

Idade: 22 anos

Período da avaliação: 01 a 22 de setembro de 2025.

Profissão: Analista de Modelagem

Escolaridade: Ensino superior incompleto (8º período – Engenharia Elétrica)

Local da avaliação: Juazeiro/BA

2. Descrição da demanda

A avaliação neuropsicológica foi solicitada pelo psiquiatra Dr. Carlos Lacerda (CREMEB 23833 / CREMEPE 21569) com o objetivo de investigar hipótese diagnóstica de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH).

A paciente GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA, 22 anos, Analista de Modelagem e estudante do 8º período de Engenharia Elétrica, relata dificuldades persistentes em manter organização, concentração e continuidade nas atividades diárias, tanto em contextos pessoais quanto profissionais e acadêmicos.

Os sintomas tornaram-se perceptíveis por volta de 2019, intensificando-se ao longo do último ano. A paciente refere procrastinação frequente, desorganização ambiental, esquecimentos recorrentes e dificuldade em sustentar o foco em tarefas prolongadas, com impacto relevante em sua rotina e produtividade. Na infância, não havia prejuízos acadêmicos significativos.

Relata que os sintomas se acentuaram após o início da vida universitária e da transição para o modo remoto de trabalho e estudos, dificultando o estabelecimento de rotina e a interação social. Embora mantenha desempenho adequado no ambiente profissional — por meio de estratégias compensatórias como cadernos de organização e ferramentas digitais — reconhece que essas estratégias não têm sido eficazes para a vida pessoal, especialmente no gerenciamento do tempo e das tarefas domésticas.

Apresenta nível cultural médio, é independente financeiramente e descreve humor depressivo, ansiedade e estresse, com episódios de isolamento social e pensamentos suicidas esporádicos (último episódio relatado dois dias antes da entrevista). Refere melhora gradual desde o início do tratamento psiquiátrico e psicoterápico, iniciado há cerca de 45 dias, com uso de Sertralina 50 mg e Atenta 60 mg.

O sono é descrito como regular (6 a 7 horas por noite), ainda que desperte cansada; o apetite encontra-se reduzido. Relata hiperfoco em temas de interesse, especialmente pesquisas sobre produtos de consumo, chegando a comprometer o descanso noturno.

No campo familiar e afetivo, mora sozinha desde 2019. Mantém relação estável com o namorado, atualmente residindo em São Paulo, e relações familiares distantes, mas sem conflitos. Tem histórico de mãe com depressão não tratada e irmã diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (nível 1), ansiedade e depressão.

A paciente descreve-se como pessoa empática, com dificuldade em impor limites e tendência a se sobrecarregar emocionalmente para ajudar os outros. Refere ansiedade em situações sociais, especialmente após um episódio de abuso em transporte público, o que contribuiu para evitar sair sozinha à noite.

De modo geral, identifica o prejuízo funcional como alto, por sentir-se limitada na capacidade de manter rotina, lidar com demandas simultâneas e sustentar atividades prazerosas.

3. Procedimentos

A avaliação neuropsicológica foi conduzida em oito sessões de 50 minutos, realizadas entre setembro e novembro de 2025, incluindo entrevista de anamnese, sessões de aplicação e sessão devolutiva. O objetivo central foi investigar o perfil cognitivo, emocional e funcional da paciente, com ênfase em atenção, memória, funções executivas, afetividade e personalidade, integrando informações provenientes de testes padronizados, entrevistas clínicas, observações comportamentais e relatos da própria paciente.

Durante todo o processo, foram adotadas estratégias para minimizar interferências relacionadas à fadiga, agitação e dificuldades de concentração, de modo a garantir um desempenho representativo das habilidades cognitivas avaliadas. As informações obtidas também foram complementadas por dados sobre escolaridade, trajetória profissional e observações clínicas realizadas ao longo das sessões.

3.1 Entrevista de anamnese

Foi realizada anamnese semidirigida, com o objetivo de coletar informações detalhadas sobre a história de vida, saúde, funcionamento diário e contexto emocional da paciente. Esse procedimento possibilitou compreender como fatores médicos, psicológicos, sociais e comportamentais influenciam o desempenho cognitivo, além de identificar áreas de vulnerabilidade e estratégias de enfrentamento já utilizadas.

3.2 Aplicação de testes psicológicos e neuropsicológicos:

Foram aplicados os seguintes instrumentos padronizados, visando análise ampla do funcionamento cognitivo, emocional e comportamental:

a) WASI – Escala Wechsler Abreviada de Inteligência

Fornece estimativa rápida do funcionamento intelectual geral, avaliando habilidades verbais e não verbais, raciocínio, compreensão, memória de trabalho e velocidade de processamento. Os resultados contribuem para a análise preliminar do perfil cognitivo e planejamento de estratégias de intervenção.

b) RAVLT – Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey

Avalia memória verbal e aprendizado episódico, permitindo analisar a capacidade de aquisição, retenção e evocação de informações verbais, bem como possíveis interferências retroativas e proativas, integrando-se à interpretação global do funcionamento cognitivo.

c) BSI – Inventário Breve de Sintomas

Instrumento para avaliação da presença e intensidade de sintomas psicológicos, como depressão, ansiedade, hostilidade e somatização. Os resultados auxiliam na identificação de áreas de sofrimento e padrões de resposta emocional.

d) BDI-II – Inventário de Depressão de Beck

Mensura a gravidade dos sintomas depressivos, avaliando humor, interesse, energia e pensamentos negativos, contribuindo para o planejamento de intervenções clínicas adequadas.

e) BHS – Escala de Desesperança de Beck

Avalia pensamentos de desesperança, expectativas negativas sobre o futuro e percepção de controle, fornecendo indicadores de risco para comprometimento emocional e vulnerabilidade psicológica.

f) EAG-A – Escala de Ansiedade Generalizada - Versão Adulta

Avalia sintomas de ansiedade generalizada, incluindo inquietação, tensão, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, irritabilidade, alterações do sono e manifestações físicas. Permite mensurar o impacto funcional da ansiedade no cotidiano e identificar vulnerabilidades psicológicas.

g) BFP – Bateria Fatorial de Personalidade

Instrumento para avaliação de traços de personalidade, padrões de comportamento, estratégias de enfrentamento, autocontrole e reatividade emocional, possibilitando compreender como as características de personalidade influenciam respostas cognitivas e comportamentais.

h) BPA-2 – Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção 2

Avalia modalidades atencionais diversas, incluindo atenção sustentada, seletiva e dividida, permitindo identificar déficits e padrões de dispersão cognitiva com impacto no desempenho cotidiano.

i) D2-R

Instrumento que avalia atenção concentrada e sustentada, bem como capacidade de concentração e velocidade de processamento visual. Mede a eficiência atencional por meio da identificação rápida e correta de estímulos-alvo em meio a distratores.

j) FDT – Teste dos Cinco Dígitos

Destinado à avaliação da atenção, velocidade de processamento e controle inibitório, fornecendo dados sobre capacidade de concentração e regulação cognitiva.

k) TOL-BR – Torre de Londres

Avalia funções executivas, incluindo planejamento, resolução de problemas, flexibilidade cognitiva e controle inibitório.

l) WCST – Teste de Classificação de Cartas de Wisconsin

Avalia flexibilidade cognitiva, capacidade de abstração, planejamento e resolução de problemas, fornecendo informações sobre perseveração, mudança de estratégias e adaptação a novas regras, integrando-se à análise das funções executivas.

m) BOLIE – Bateria Online de Inteligência Emocional

Avalia inteligência emocional em seis dimensões principais: compreensão emocional, sociabilidade, velocidade emocional, positividade, regulação emocional e empatia.

n) SRS-2 – Escala de Responsividade Social-2 (Auto e Heterorrelato)

Investiga habilidades sociais, comunicação interpessoal e comportamentos adaptativos, auxiliando na identificação de dificuldades de interação social e percepção de sinais sociais.

o) BDEFS – Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley

Avalia déficits nas funções executivas em contextos cotidianos, incluindo planejamento, organização, memória de trabalho, autorregulação emocional e controle de impulsos, identificando dificuldades com impacto funcional.

p) EPF-TDAH – Escala de Prejuízos Funcionais no TDAH

Mensura o impacto funcional das características do TDAH em atividades diárias, relações interpessoais e desempenho profissional/acadêmico, oferecendo base para o planejamento terapêutico.

q) ESAVI A E B – Escala de Avaliação da Impulsividade – Formas A e B

Avalia impulsividade em adultos em quatro dimensões principais: falta de concentração e persistência, controle cognitivo, planejamento futuro e audácia/temeridade.

3.3 Critérios de Interpretação

Os resultados foram analisados considerando normas brasileiras e internacionais adequadas à faixa etária, escolaridade e sexo da paciente. Foram ponderados fatores como motivação, fadiga, nível de ansiedade e estratégias de enfrentamento, garantindo interpretação crítica e integrada, com foco no impacto funcional e aplicabilidade clínica dos achados.

4. Análise

4.1. Integração Geral dos Dados

A análise integrada das informações provenientes da anamnese, entrevistas clínicas, observações comportamentais e resultados dos instrumentos neuropsicológicos e psicológicos evidencia um funcionamento cognitivo global preservado, com recursos intelectuais médios-superiores e desempenho consistente em raciocínio verbal e não verbal. GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA demonstra eficiência nas habilidades de planejamento, resolução de problemas, memória e atenção concentrada, embora apresente oscilações em atenção dividida e controle inibitório, especialmente em situações de múltiplas demandas ou estimulação intensa.

No plano emocional, os resultados apontam para sofrimento psíquico clinicamente relevante, com sintomas depressivos e ansiosos de intensidade elevada, além de tendência à autocrítica, desesperança e preocupação excessiva. Observa-se alta sensibilidade afetiva e vulnerabilidade emocional, acompanhadas de dificuldade em regular emoções e manter estabilidade interna em contextos de sobrecarga.

O perfil de personalidade revela traços de introversão, dependência afetiva e insegurança, combinados com elevada empatia, senso ético e abertura à experiência, compondo um funcionamento de base sensível, reflexiva e emocionalmente permeável. Esse conjunto de características favorece profundidade relacional e capacidade empática, mas também contribui para sobrecarga emocional, autodepreciação e oscilação regulatória diante de pressões externas.

De forma geral, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresenta intelecto preservado, boa capacidade de aprendizagem e insight clínico desenvolvido, porém comprometimento significativo do bem-estar emocional, marcado por fadiga psíquica, baixa autorregulação e dificuldade em sustentar rotinas e prioridades em contextos de alta demanda. O conjunto de achados indica funcionamento cognitivo adaptativo, mas emocionalmente vulnerável, com impacto direto do estado afetivo sobre a atenção, motivação e desempenho funcional.

4.2. Desempenho Cognitivo e Funcional

Inteligência

Subtestes / Escala	WASI (Escala Wechsler Abreviada de Inteligência)		
	Ponto composto – QI	Percentil	Classificação
Verbal (QIV)	117	87	Médio Superior
Execução (QIE)	111	77	Médio Superior
QI Total (QIT)	117	87	Médio Superior

A Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) foi utilizada para estimar o funcionamento intelectual geral da paciente, abrangendo componentes verbais e não verbais.

A paciente apresentou QI Verbal de 117 (percentil 87), QI de Execução de 111 (percentil 77) e QI Total de 117 (percentil 87), todos classificados como Médio Superior, indicando desempenho acima da média esperada para sua faixa etária e escolaridade.

Na análise dos subtestes, observou-se bom repertório vocabular e adequada compreensão verbal, sugerindo desenvolvimento sólido das habilidades cristalizadas e domínio de conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória acadêmica. O desempenho em Cubos demonstrou habilidades visuoespaciais preservadas, com boa integração visuomotora e organização espacial eficiente. Nos subtestes Semelhanças e Raciocínio Matricial, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA evidenciou boa capacidade de abstração, raciocínio lógico e flexibilidade cognitiva, sustentando coerência e clareza na formulação de respostas.

De modo geral, o perfil sugere funcionamento intelectual globalmente preservado, com potencial cognitivo adequado para atividades que demandam raciocínio analítico, aprendizagem de novas informações e resolução de problemas complexos. O equilíbrio entre as habilidades verbais e não verbais também indica boa adaptabilidade cognitiva a contextos diversos, compatível com seu nível educacional e histórico de desempenho acadêmico.

Atenção e Prejuízo Funcional

BPA – 2			
Atenção	Pontos	Percentil	Classificação
Atenção Concentrada – AC	113	75	Médio Superior
Atenção Dividida – AD	73	25	Médio Inferior
Atenção Alternada – AA	113	60	Médio Superior
Atenção Geral – AG	299	60	Médio Superior

A paciente apresentou desempenho globalmente satisfatório nas modalidades atencionais, com perfil caracterizado por atenção concentrada e alternada acima da média, e atenção dividida ligeiramente abaixo da média, conforme os parâmetros normativos para sua faixa etária (18 a 25 anos).

Na atenção concentrada (percentil 75), observou-se facilidade em focalizar estímulos relevantes e inibir distrações, demonstrando boa capacidade de manutenção do foco diante de múltiplos estímulos concorrentes.

Na atenção alternada (percentil 60), o desempenho também foi superior à média, indicando boa flexibilidade cognitiva para alternar o foco entre diferentes tarefas ou estímulos de forma organizada e eficiente.

Em contrapartida, a atenção dividida (percentil 25) apresentou desempenho ligeiramente inferior à média, sugerindo dificuldade em gerenciar simultaneamente múltiplas fontes de informação, especialmente em contextos que exigem alternância rápida de foco sob pressão temporal.

A atenção geral (percentil 60) se manteve dentro da faixa médio-superior, reforçando que as habilidades de sustentação e focalização atencional estão preservadas, apesar de pequenas oscilações no controle de estímulos múltiplos.

Do ponto de vista funcional, o perfil sugere que GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA tende a apresentar bom desempenho em atividades que exigem foco contínuo e mudança estruturada de tarefas, mas pode manifestar leve sobrecarga cognitiva em situações que requerem a divisão simultânea da atenção, como contextos de multitarefa ou ambientes com alto volume de estímulos externos.

D2-R				
	Pontuação Bruta	Escore Z	Percentil	Classificação
OAP Objetos-alvo processados	219	115	92	Alto
DC Desempenho da concentração	167	108	77	Alto
E% Porcentagem de erros	23,74	89	15	Baixo

O desempenho de GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA no Teste D2-R evidenciou atenção concentrada e sustentada dentro da faixa alta, com perfil produtivo e boa eficiência cognitiva.

A paciente apresentou OAP = 219 (percentil 92) e Desempenho da Concentração (DC) = 167 (percentil 77), ambos classificados como Altos, indicando excelente capacidade para manter o foco em estímulos-alvo relevantes, associada a velocidade adequada de processamento visual e bom controle atencional diante de tarefas repetitivas e de longa duração.

A porcentagem de erros (E% = 23,74; percentil 15) situou-se ligeiramente abaixo da média, sugerindo tendência a respostas impulsivas ou a uma priorização da velocidade em detrimento da precisão. Esse padrão é compatível com indivíduos que mantêm alto ritmo de trabalho, mas podem incorrer em lapsos atencionais sutis quando expostos a tarefas extensas ou sob pressão temporal.

O conjunto dos resultados indica bom controle atencional, alta capacidade de sustentação do foco e produtividade cognitiva eficiente, com pequena propensão a erros de descuido quando a tarefa demanda rapidez e monitoramento simultâneo.

FDT						
Pontuação	Leitura	Contagem	Escolha	Alternância	Inibição	Flexibilidade
PD (*)	26	21	32	55	06	34
Erros	00	00	00	00		
Percentil	25	75	75	25	95	5-25

* Tempos de execução em segundos

O Teste dos Cinco Dígitos (FDT) teve como objetivo avaliar atenção, velocidade de processamento, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA demonstrou desempenho dentro da média a acima da média na maioria das etapas, com padrão de respostas preciso e consistente, sem ocorrência de erros em nenhuma das condições avaliadas.

Os tempos de execução indicaram desempenho dentro da média nas etapas de Leitura (percentil 25) e Alternância (percentil 25), acima da média em Contagem e Escolha (percentis 75) e muito acima da média na condição de Inibição (percentil 95), sugerindo

excelente capacidade de controle atencional e inibitório, com adequada autorregulação diante de estímulos competitivos.

A etapa de Flexibilidade (percentil entre 5–25) revelou leve lentificação no tempo de resposta, o que pode refletir dificuldade momentânea em alternar rapidamente entre regras cognitivas quando há necessidade de adaptação simultânea de atenção e resposta motora. Esse achado, no entanto, não comprometeu a precisão global da tarefa e deve ser interpretado em conjunto com o bom desempenho nas demais etapas e ausência de erros.

De modo geral, o perfil no FDT sugere atenção sustentada e seletiva bem preservadas, excelente inibição de impulsos e velocidade de processamento adequada, com pequena variação em tarefas que exigem alternância rápida entre estímulos e estratégias cognitivas.

EPF-TDAH				
Área	Número de itens	Escore Bruto	Escore T	Interpretação do Prejuízo
Acadêmica	8	18	73	Leve
Profissional	10	12	59	Sem prejuízo
Afetivo-sexual	8	16	62	Leve
Doméstica	7	23	>90	Severo
Social	9	17	67	Leve
Financeira	7	09	58	Sem prejuízo
Saúde	6	12	62	Leve
Trânsito	6	00	43	Sem prejuízo
Risco Legal	5	00	48	Sem prejuízo

A aplicação da EPF-TDAH teve como finalidade mensurar o impacto funcional das características associadas ao TDAH em diferentes domínios da vida cotidiana. GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresentou prejuízos leves a severos em cinco das nove áreas avaliadas, com destaque para o domínio doméstico, classificado como severamente comprometido ($T > 90$), indicando dificuldades significativas na organização e manutenção das rotinas do lar.

Foram observados prejuízos leves nas áreas acadêmica ($T = 73$), afetivo-sexual ($T = 62$), social ($T = 67$) e de saúde ($T = 62$), refletindo impacto funcional moderado, especialmente em contextos que exigem constância, gerenciamento de tempo e autocuidado. Já os domínios profissional ($T = 59$), financeiro ($T = 58$), trânsito ($T = 43$) e risco legal ($T = 48$) não apresentaram prejuízos clinicamente relevantes, sugerindo que a paciente mantém bom desempenho e autorregulação em contextos de maior estrutura e demanda externa.

De acordo com os critérios do DSM-5-TR, a presença de prejuízo significativo nas áreas acadêmica e social sustenta a relevância clínica das dificuldades atencionais relatadas, corroborando a hipótese de comprometimento funcional associado ao perfil atencional previamente identificado nos testes cognitivos.

Os resultados obtidos nos instrumentos aplicados apontam para um perfil atencional predominantemente preservado, com eficiência elevada em tarefas de foco sustentado, seletividade e controle inibitório, mas com oscilações sutis em demandas de divisão e alternância atencional.

O desempenho na BPA-2 e no D2-R indica capacidade robusta de concentração e processamento visual rápido, enquanto o FDT revelou excelente controle inibitório e apenas leve lentificação em tarefas de flexibilidade cognitiva. A EPF-TDAH, por sua vez, evidenciou que, embora as funções atencionais básicas estejam preservadas, há impactos funcionais perceptíveis na rotina doméstica, acadêmica e social, sugerindo que a queixa de desorganização e dispersão cotidiana tem índole comportamental e executiva, mais do que déficits atencionais estruturais.

De forma integrada, os achados sugerem que GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA possui recursos cognitivos adequados para sustentar o foco e executar tarefas complexas, mas apresenta dificuldades contextuais na autogestão e organização da rotina, o que repercute em prejuízos funcionais específicos e sobrecarga emocional, especialmente em ambientes com menor estrutura externa.

Memória

Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (RAVLT)				
	Categorias	Pontuação	Percentil	Classificação
Primeiras etapas de aprendizagem	A1	07	50	Médio
	A2	09	50	Médio
	A3	11	50	Médio
	A4	12	50	Médio
	A5	13	50	Médio
Distrator	B1	06	50	Médio
Evocação imediata	A6	15	95	Médio Superior
Evocação tardia	A7	15	95	Médio Superior
Reconhecimento		15	95	Médio Superior
	Escore total	52	50-75	Médio
Índices de aprendizagem	Aprendizagem ao longo das tentativas	17	50	Médio
Índice de retenção	Velocidade de Esquecimento	01	50	Médio
Índices de interferência	Interferência Proativa	0,86	50	Médio
	Interferência Retroativa	1,15	>95	Superior

A paciente apresentou desempenho global dentro da média a médio-superior no Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT), indicando processos de codificação, armazenamento e recuperação de informações verbais preservados.

Durante as cinco tentativas iniciais de aprendizagem (A1–A5), GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA manteve desempenho médio e consistente, evidenciando boa capacidade de aquisição progressiva ao longo das repetições e atenção auditiva adequada. O escore total de aprendizagem (52 pontos, percentil entre 50–75) demonstra ritmo estável de incorporação de informações sem sinais de fadiga cognitiva.

Na etapa distratora (B1), o desempenho permaneceu médio, sugerindo resistência satisfatória à interferência de novos estímulos. Já nas fases de evocação imediata (A6), evocação tardia (A7) e reconhecimento, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA alcançou percentis 95, classificados como médio-superior, indicando excelente retenção e recuperação de material aprendido, com baixo índice de esquecimento (Velocidade de Esquecimento = 1, percentil 50).

Os índices de interferência proativa (0,86; percentil 50) e interferência retroativa (1,15; >95) reforçam a preservação dos mecanismos de consolidação mnemônica, com alta

resistência à interferência e eficiente controle de recuperação, típicos de indivíduos com organização cognitiva adequada e estratégias de recordação funcionais.

De modo geral, o desempenho de GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA no RAVLT demonstra memória verbal preservada, com bom aprendizado, retenção e evocação, além de excelente reconhecimento e controle da interferência, compatíveis com seu nível intelectual e histórico acadêmico.

Funções Executivas

TOL-BR		
Escore Total	Percentil	Classificação
50	55	Média

No Teste Torre de Londres – versão brasileira (TOL-BR), a paciente obteve escore total de 50 (percentil 55), classificado como médio, indicando planejamento e raciocínio lógico dentro da faixa de normalidade para sua faixa etária e escolaridade.

Durante a realização da tarefa, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA demonstrou boa compreensão das instruções, organização adequada das etapas e capacidade satisfatória de antecipar consequências antes da execução. O padrão de respostas sugere planejamento funcional preservado, embora sem indícios de desempenho acima da média.

Esses resultados indicam que a paciente é capaz de estruturar e monitorar estratégias cognitivas de forma eficiente, especialmente quando as demandas são claras e o ambiente apresenta regras definidas e feedback imediato. Em contextos menos estruturados, no entanto, pode ocorrer redução da iniciativa ou dificuldade em manter a sequência planejada de ações, o que se alinha ao relato clínico de desorganização cotidiana.

De modo geral, o desempenho no TOL-BR reflete funções executivas preservadas, com planejamento compatível com o esperado, coerente com o perfil cognitivo global previamente descrito.

No WCST, instrumento que avalia formação de conceitos, flexibilidade cognitiva, planejamento e capacidade de adaptação a novas regras, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresentou desempenho global dentro da média a acima da média, indicando eficiente controle executivo e raciocínio conceitual preservado.

A paciente completou seis categorias, sem fracassos em manter o contexto e com índice de “Aprendendo a Aprender” de 6,93%, o que reflete boa capacidade de aprender com o feedback e ajustar estratégias cognitivas ao longo da tarefa.

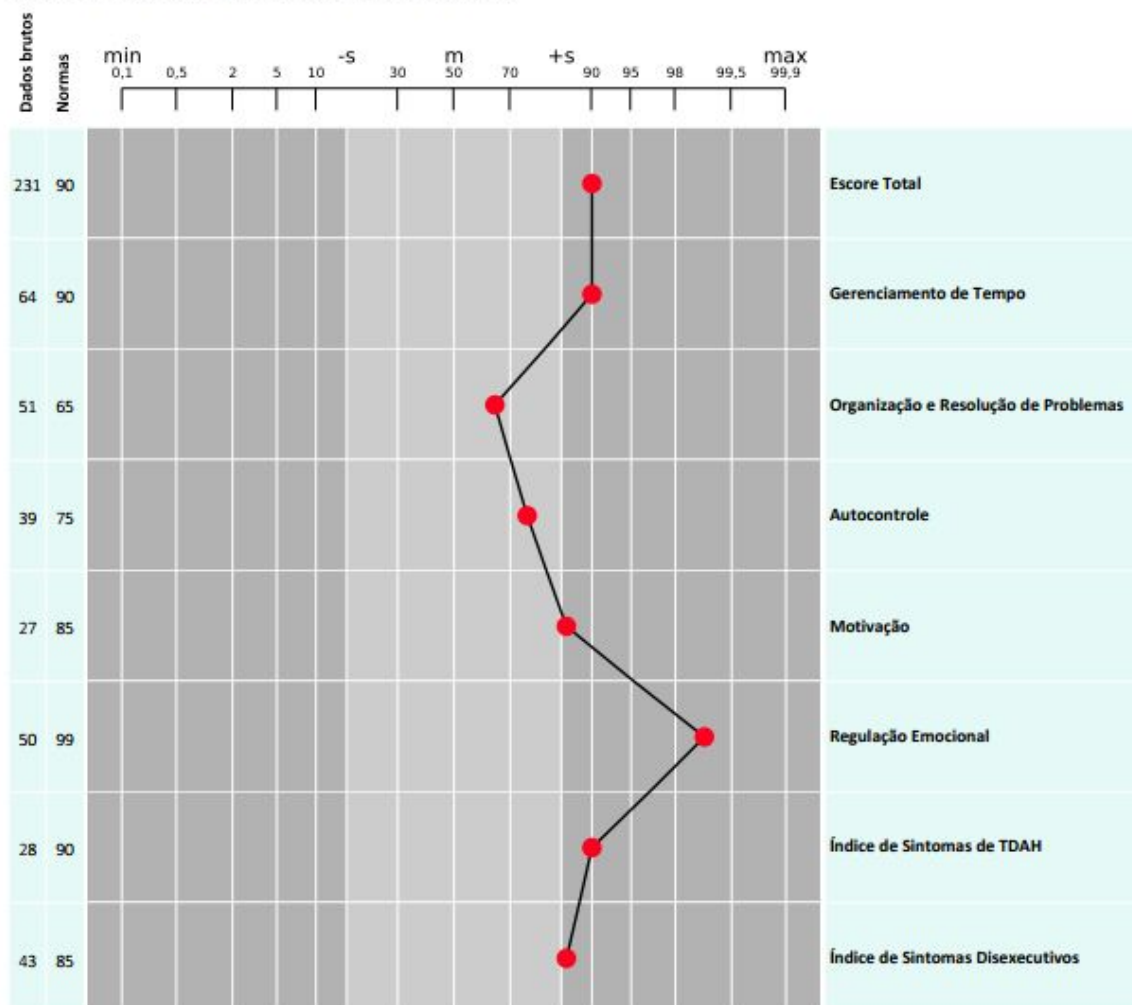
Os indicadores quantitativos demonstraram percentuais de erros (27,1%) e de respostas perseverativas (17,76%) dentro da faixa média, enquanto as respostas de nível conceitual (64,49%; escore T = 57; percentil 74) indicam adequada formação de conceitos e abstração verbal. A paciente evidenciou boa flexibilidade mental e baixa tendência à perseveração, adaptando-se rapidamente às mudanças de critérios.

De modo geral, o desempenho de GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA no WCST revela funções executivas preservadas, com raciocínio lógico, planejamento e flexibilidade

cognitiva compatíveis com o esperado para sua faixa etária e nível educacional. Esses resultados corroboram o funcionamento executivo observado no TOL-BR e reforçam a presença de estratégias cognitivas eficientes e ajustadas ao contexto.

BDEFS - Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley - Versão Longa

Amostra Geral - dos 18 aos 24 anos - Escore Percentil



A paciente obteve escore total de 231 (percentil 90), classificado como “quase deficiente ou no limite”, sugerindo indícios de comprometimento executivo leve em atividades do cotidiano. O perfil revela um funcionamento executivo heterogêneo, com forças em algumas dimensões e fragilidades em outras, especialmente em aspectos relacionados à autorregulação e ao manejo emocional.

Os resultados apontaram déficits mais evidentes nas áreas de Regulação Emocional (percentil 99) e Gerenciamento de Tempo (percentil 90), indicando tendência a oscilações emocionais intensas, dificuldade em inibir respostas afetivas e desafios em planejar e cumprir prazos ou sequenciar tarefas ao longo do tempo. Também se observam indícios leves de dificuldades em Organização e Resolução de Problemas (percentil 65), Autocontrole (percentil 75) e Motivação (percentil 85), sugerindo que, embora mantenha capacidade cognitiva preservada, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA tende a

apresentar oscilações no engajamento e na persistência diante de demandas prolongadas.

O Índice de Sintomas de TDAH (percentil 90) e o Índice de Sintomas Disexecutivos (percentil 85) indicam frequência significativa de comportamentos associados a desatenção, impulsividade e desorganização, ainda que dentro de limites funcionais, o que reforça a hipótese de dificuldades executivas sutis, mais evidentes em ambientes com menor estrutura externa e alto grau de autonomia.

De modo geral, o padrão identificado no BDEFS revela recursos executivos preservados em termos cognitivos, mas fragilizados em termos comportamentais e emocionais, especialmente no que diz respeito ao autogerenciamento, controle da impulsividade emocional e manutenção da motivação ao longo do tempo. Tais resultados estão alinhados com os relatos de desorganização, variações de humor e sobrecarga cognitiva descritos na anamnese e corroboram a necessidade de intervenções voltadas ao treinamento de autorregulação emocional e gerenciamento do tempo.

A análise integrada dos instrumentos aplicados (TOL-BR, WCST e BDEFS) indica que GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresenta funções executivas globalmente preservadas, com planejamento, flexibilidade cognitiva, raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas dentro da média esperada para sua faixa etária e escolaridade. Nos testes de execução prática (TOL-BR e WCST), demonstrou eficiência em planejar, testar e ajustar estratégias cognitivas, mantendo boa capacidade de adaptação às mudanças de regras e monitoramento de desempenho.

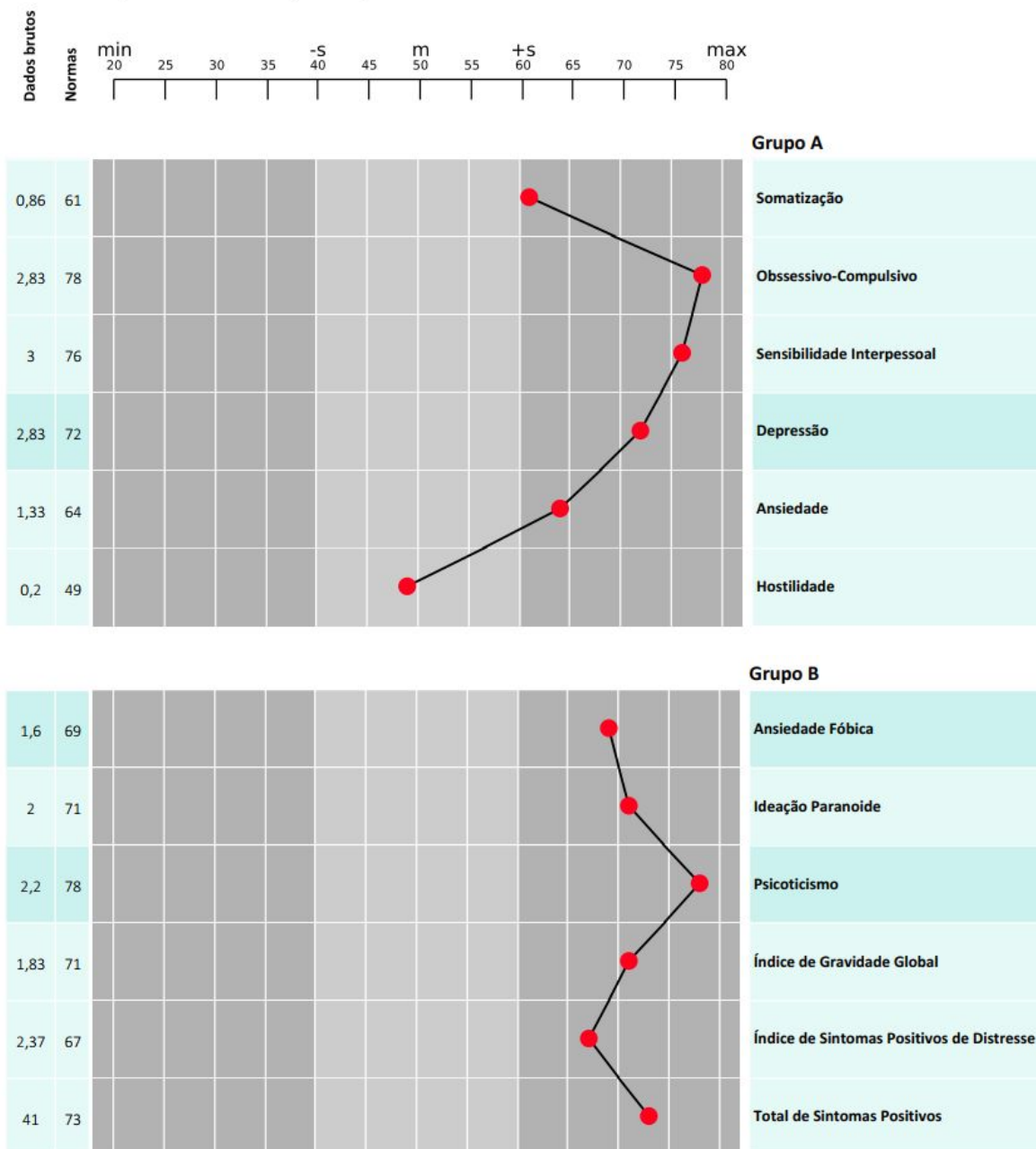
No entanto, quando as funções executivas são analisadas em termos de comportamento cotidiano e autorregulação emocional, como mensurado pela Escala de Barkley (BDEFS), observam-se vulnerabilidades sutis, especialmente nos domínios de regulação emocional, gerenciamento do tempo e autogerenciamento motivacional. Esse padrão sugere que, embora as habilidades cognitivas associadas ao funcionamento executivo estejam preservadas, a paciente apresenta maior sensibilidade a fatores emocionais e contextuais, o que pode comprometer o uso consistente desses recursos em situações do dia a dia.

Assim, o conjunto dos achados aponta para um funcionamento executivo adequado no plano cognitivo, mas com manifestações comportamentais que refletem dificuldades de autogestão e controle emocional, compatíveis com um perfil de disfunção executiva leve, frequentemente observado em quadros de variação atencional e autorregulatória, sem evidências de prejuízos estruturais nas funções mentais superiores.

Aspectos emocionais e sintomas psicológicos

Inventário Breve de Sintomas - Padrão

Adultos não pacientes - Escore T (50+10z)



Os resultados do Inventário Breve de Sintomas (BSI) indicam a presença de sofrimento psicológico significativo. A elevação da dimensão obsessivo-compulsiva sugere tendência a preocupações recorrentes, necessidade de controle e rigidez cognitiva, associadas à percepção de sobrecarga e à dificuldade em interromper ciclos de pensamento. A dimensão depressão indica redução de interesse e motivação, sentimentos de desânimo e desesperança, enquanto a sensibilidade interpessoal aponta para autocrítica exacerbada, insegurança social e sentimentos de inferioridade.

As dimensões ideação paranoide e psicoticismo, embora elevadas, devem ser interpretadas com cautela, uma vez que, na ausência de indicadores clínicos de psicose, esses resultados costumam refletir experiências subjetivas de desconfiança, isolamento e alienação emocional em momentos de sofrimento intenso — o que é compatível com o contexto relacional e afetivo descrito na anamnese.

De modo geral, o perfil no BSI demonstra estado emocional fragilizado e padrão de sofrimento multifatorial, marcado por ansiedade, ruminação, autodepreciação e sobrecarga cognitiva, sugerindo a presença de estresse psicológico clinicamente relevante, ainda que dentro de limites funcionais, com preservação da capacidade crítica e insight sobre as próprias dificuldades.

No Inventário de Depressão de Beck – Segunda Edição (BDI-II), GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA obteve pontuação total de 42, o que corresponde a um nível de intensidade grave dos sintomas depressivos.

O perfil apresentado caracteriza-se por tristeza intensa, desesperança quanto ao futuro, sentimentos de fracasso e culpa persistentes, autodepreciação e perda de prazer em atividades antes valorizadas. Observam-se também cansaço acentuado, irritabilidade, insônia inicial, indecisão e dificuldade de concentração, sugerindo comprometimento funcional do humor e da motivação.

Destacam-se ainda pensamentos autodepreciativos e ideação suicida passiva (“gostaria de me matar”), sem relato de planejamento ou tentativa recente, mas que indicam risco emocional relevante e necessidade de monitoramento clínico próximo, com ênfase em estratégias de suporte psicoterápico e continuidade do acompanhamento psiquiátrico.

De modo geral, os resultados do BDI-II refletem um estado depressivo de alta intensidade, compatível com transtorno depressivo em fase ativa, marcado por fadiga, desesperança e sentimentos de culpa persistentes, com preservação do insight e disposição para tratamento — fatores importantes para o manejo clínico e reabilitação emocional.

Na Escala de Desesperança de Beck (BHS), GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA obteve pontuação bruta de 12 (valor normativo = 62), o que corresponde a um nível moderado de desesperança. Esse resultado indica visão pessimista e crenças negativas moderadas em relação ao futuro, associadas à percepção de que os próprios esforços tendem a não resultar em êxito ou mudança significativa.

O perfil sugere tendência a pensamentos autodepreciativos e expectativa reduzida de melhora emocional, compatível com quadros depressivos ativos, mas ainda sem evidência de perda completa da esperança ou desistência frente à vida. Apesar do viés pessimista, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA demonstra capacidade crítica e preservação parcial da confiança em sua própria superação, o que configura um fator de proteção relevante em termos psicoterápicos e de adesão ao tratamento.

Em conjunto com os resultados do BDI-II e do BSI, o desempenho na BHS reforça a presença de sofrimento emocional significativo, porém com recursos cognitivos e afetivos que favorecem a reestruturação do pensamento e a recuperação gradual da vitalidade emocional.

Na EAG-A (Versão Adulta), GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresentou nível alto de ansiedade generalizada (percentil 85), indicando prejuízo e sofrimento acentuados decorrentes de preocupação excessiva, tensão constante e dificuldade para controlar pensamentos antecipatórios.

Os domínios específicos revelaram Dificuldade de Concentração (percentil 95) e Problemas de Sono (percentil 85) em faixas altas, refletindo impacto cognitivo e fisiológico significativo da ansiedade, com interferência direta em atenção sustentada, foco e qualidade do descanso. Também foram observados níveis médio-altos de Inquietação (percentil 75) e Irritabilidade (percentil 75), sugerindo hiperativação emocional e baixa tolerância à frustração em situações de sobrecarga.

O fator Pensamentos Preocupantes (percentil 90) reforça a presença de preocupações persistentes e de caráter catastrófico, centradas em eventos futuros, compatíveis com o padrão ansioso-ruminativo descrito na anamnese e nos demais instrumentos afetivos. Os Sintomas Físicos (percentil 61) permanecem dentro da faixa média-alta, indicando manifestações somáticas secundárias ao estado de alerta contínuo.

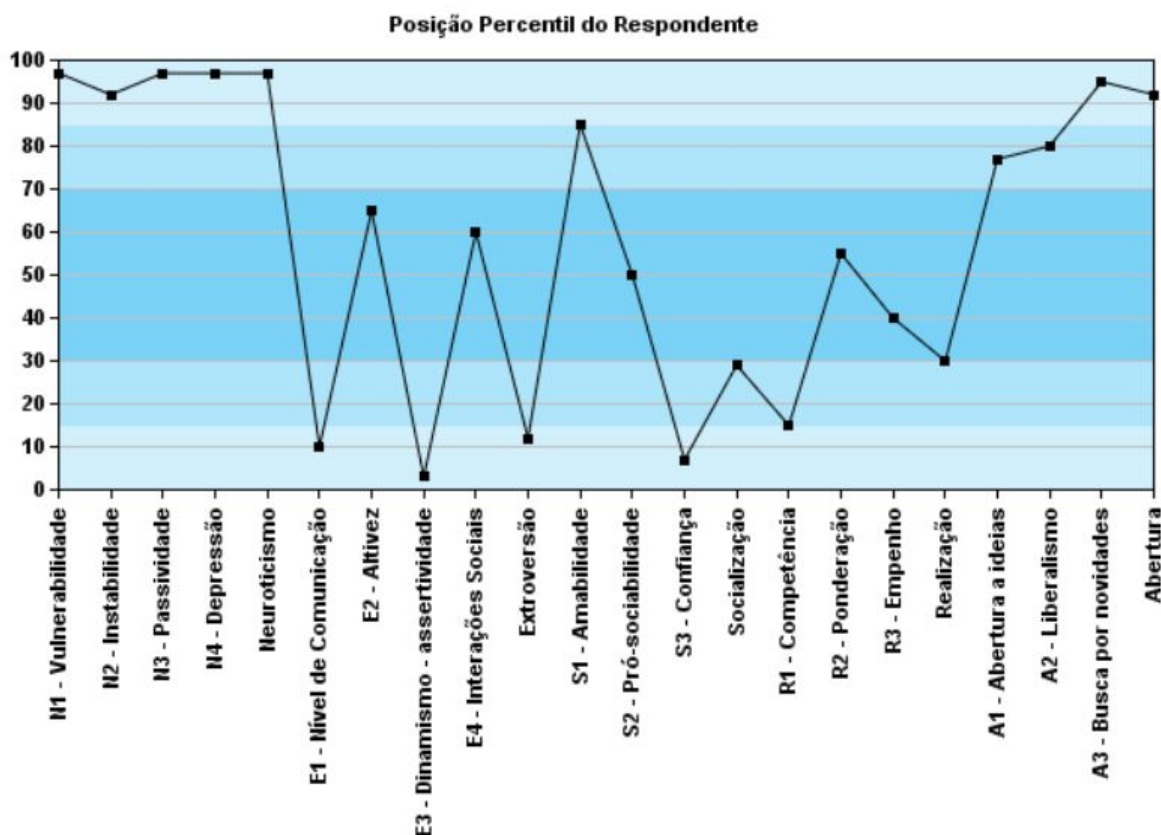
Em conjunto, o perfil da EAG-A aponta para uma ansiedade generalizada de intensidade clínica, com expressiva interferência no funcionamento cognitivo e emocional cotidiano, caracterizada por preocupação excessiva, fadiga, tensão e comprometimento da concentração e do sono.

A integração dos instrumentos aplicados (BSI, BDI-II, BHS e EAG-A) evidencia a presença de sofrimento emocional clinicamente relevante, com predomínio de sintomas depressivos e ansiosos, associados a padrões de pensamento autodepreciativos e preocupações excessivas. O perfil afetivo da paciente é marcado por tristeza persistente, desesperança moderada, tensão constante e sentimentos recorrentes de culpa e inadequação, compondo um quadro de comprometimento emocional significativo, mas com preservação parcial do insight e dos recursos de enfrentamento.

Os resultados indicam nível grave de depressão (BDI-II = 42), com fadiga, perda de prazer, dificuldade de concentração e ideação suicida passiva, além de nível moderado de desesperança (BHS = 12), caracterizando visão negativa sobre o futuro, embora ainda acompanhada de capacidade reflexiva e crítica sobre si. O BSI revelou elevação clínica em múltiplas dimensões (obsessivo-compulsiva, depressão, ansiedade e sensibilidade interpessoal), sugerindo ruminação, rigidez cognitiva e autocrítica elevada.

A EAG-A confirmou a presença de ansiedade generalizada em nível alto, com impacto direto em sono, concentração e regulação emocional, compatível com o relato de inquietação, cansaço e sobrecarga cognitiva. Em conjunto, os resultados descrevem uma paciente que vivencia sofrimento psíquico expressivo, com vulnerabilidade emocional e autorregulatória, mas mantém lucidez, adesão ao tratamento e abertura ao processo terapêutico — fatores que se configuram como indicadores de bom prognóstico clínico.

Personalidade e funcionamento social



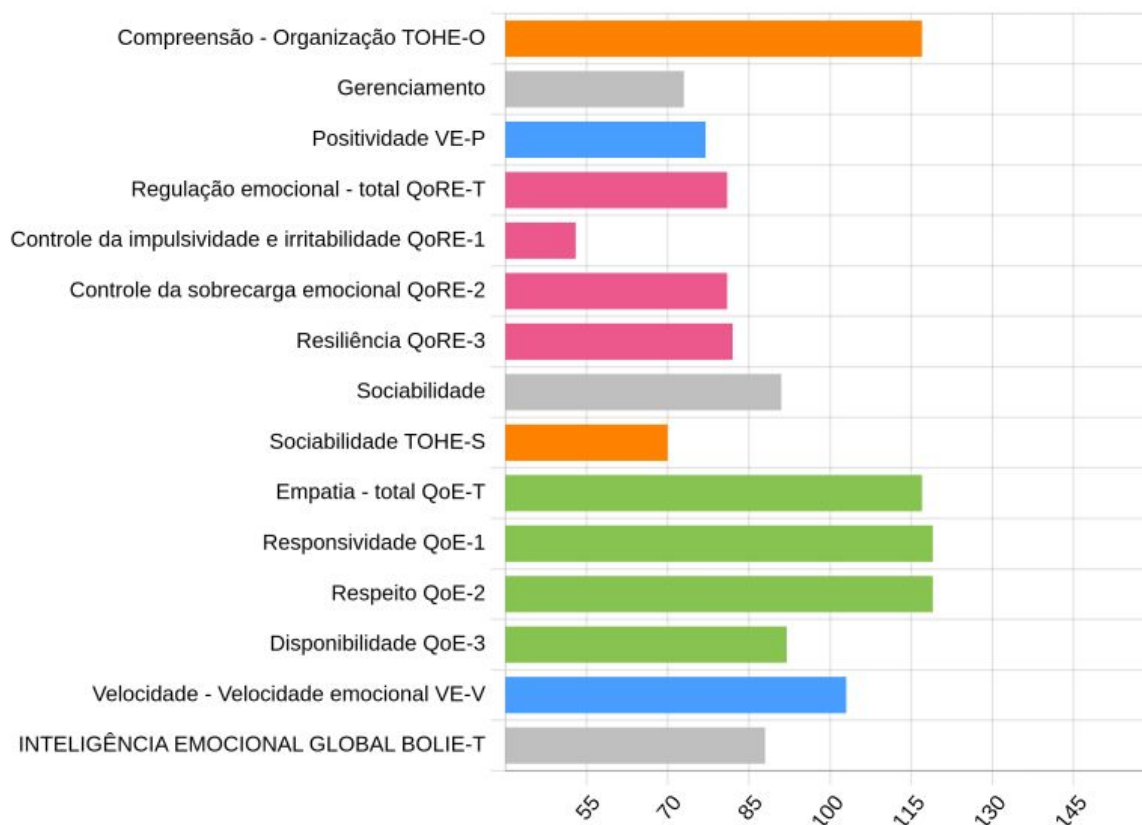
O perfil de GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA na Bateria Fatorial de Personalidade (BFP) caracteriza-se por níveis muito altos de Neuroticismo (percentil >95), evidenciando sensibilidade emocional acentuada, baixa autoestima e alta dependência afetiva, com tendência à insegurança, medo de rejeição e dificuldade para lidar com críticas e frustrações. Observa-se instabilidade emocional significativa, com oscilações de humor e impulsividade diante de desconfortos psicológicos, bem como traços de passividade e procrastinação, que contribuem para dificuldades na manutenção do foco e continuidade de tarefas de maior complexidade.

No fator Extroversão, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresentou escores muito baixos (percentil <10), especialmente nas facetas de comunicação (percentil 10) e dinamismo/assertividade (percentil <5), sugerindo tendência à introversão, retraimento social e baixa iniciativa em contextos interpessoais, ainda que mantenha um padrão de interação adequado quando em ambientes seguros e estruturados.

O fator Socialização revelou níveis altos de amabilidade (percentil 85), o que indica forte preocupação com o bem-estar dos outros, comportamento cooperativo e empático, embora a baixa confiança interpessoal (percentil <5) a torne mais suscetível a sentimentos de desconfiança e insegurança em vínculos afetivos.

Nos fatores Realização e Abertura, observam-se traços de autocritica e dúvida sobre a própria competência (percentil 15 em Competência), mas também elevada abertura a ideias e novidades (percentil >90), refletindo curiosidade intelectual, flexibilidade de pensamento e interesse por experiências diversificadas.

De forma geral, o perfil de personalidade de GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA evidencia hipersensibilidade emocional, retraimento social e autocrítica elevada, combinadas a traços de empatia, criatividade e abertura a novos contextos, compondo um funcionamento de personalidade marcado por vulnerabilidade afetiva e necessidade de segurança relacional, mas também com potencial adaptativo elevado quando amparada em ambientes acolhedores e previsíveis.



A paciente apresentou nível global de inteligência emocional dentro da média, tendendo a baixo (percentil 21), o que indica dificuldade moderada em regular emoções e reconhecer de forma funcional os próprios estados afetivos, ainda que mantenha boa capacidade de compreensão emocional e empatia em relação aos outros.

O fator Compreensão Emocional (percentil 87) revelou capacidade elevada de reconhecer as causas e transições das emoções, além de alta empatia e percepção das expressões emocionais alheias — aspecto que favorece vínculos interpessoais e sensibilidade social. Em contraste, o fator Gerenciamento Emocional (percentil 4) e a dimensão Regulação Emocional Total (percentil 10) indicam dificuldade significativa de autorregulação, com baixa tolerância à frustração e dificuldade para conter impulsos e irritabilidade (percentil <1).

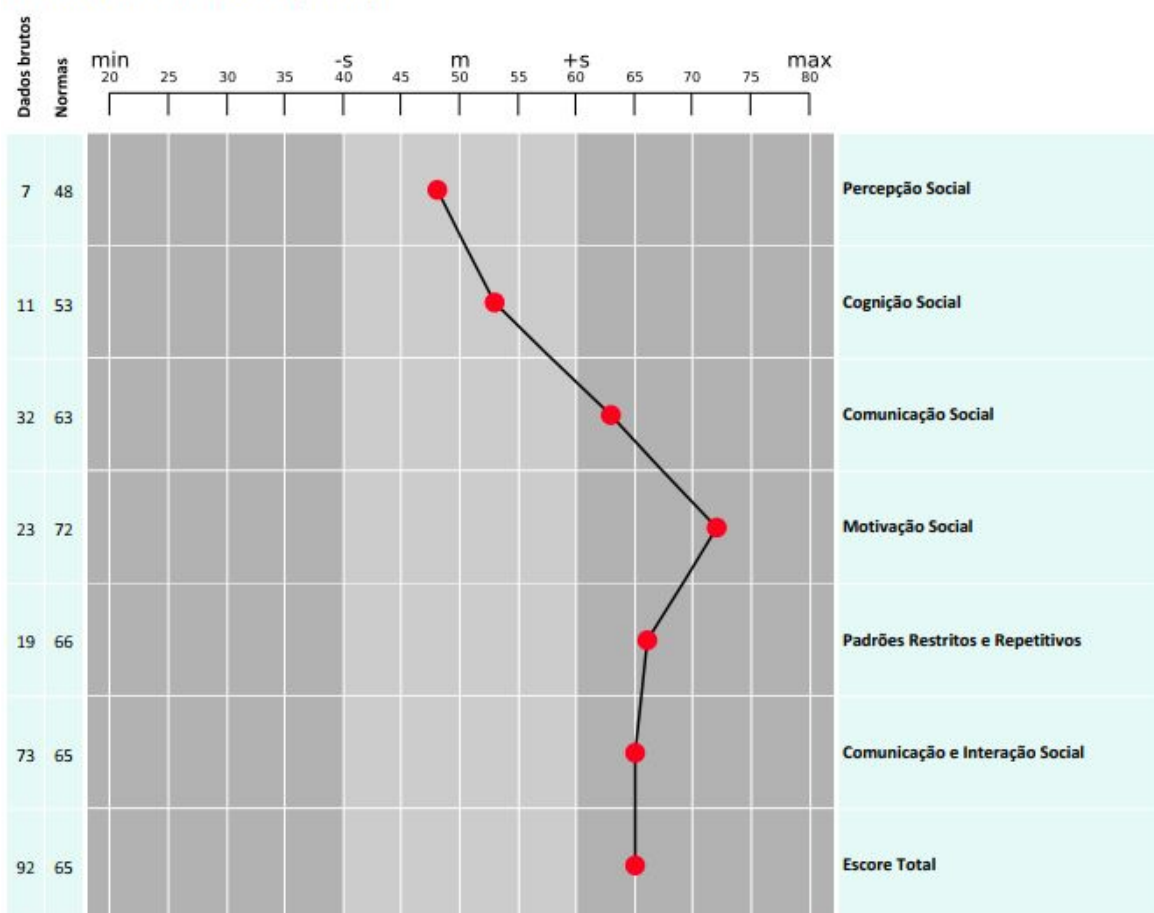
O domínio Sociabilidade (percentil 27) demonstra interações adequadas, porém marcadas por retraimento e insegurança relacional, enquanto a Empatia Total (percentil 87) e suas facetas Responsividade (percentil 90) e Respeito (percentil 90) reforçam alta

empatia cognitiva e afetiva, revelando forte capacidade de compreensão e acolhimento emocional do outro.

De modo geral, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresenta um perfil emocional assimétrico, no qual a alta sensibilidade e empatia coexistem com baixa regulação interna e dificuldade de manejo emocional, favorecendo quadros de sobrecarga, exaustão e oscilações afetivas intensas. Esse padrão sugere que, embora possua recursos emocionais elevados para compreender o outro, a paciente encontra desafios em direcionar esses recursos para si mesma, o que reforça a necessidade de intervenções voltadas ao fortalecimento da autorregulação, autocuidado e autocompaixão.

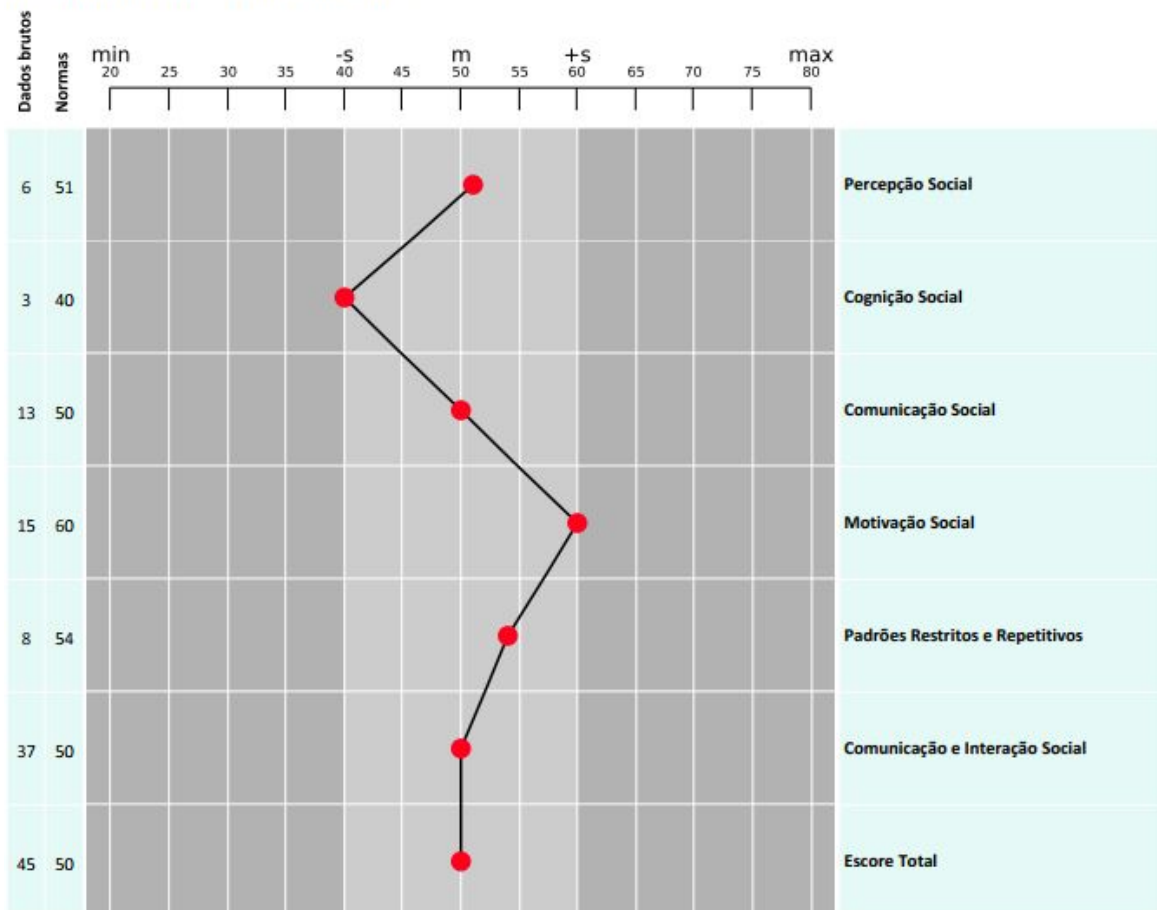
Escala de Responsividade Social - 2 - Adulto Autorrelato

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)



Escala de Responsividade Social - 2 - Adulto Heterorrelato

Heterorrelato Adulto - Escore T (50+10z)



Os resultados obtidos na SRS-2 (autorrelato e heterorrelato) indicam funcionamento social global dentro dos limites da normalidade, sem presença de prejuízos clinicamente significativos compatíveis com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No autorrelato, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresentou escore total T = 65 (nível leve), sugerindo sutilezas em comportamentos sociais recíprocos, especialmente nas dimensões motivação social (T = 72) e padrões restritos e repetitivos (T = 66). Tais resultados refletem tendência à evitação social, timidez e rigidez comportamental diante de situações novas ou estressoras, aspectos também descritos por ela em anamnese e em outros instrumentos emocionais, podendo estar relacionados à ansiedade social e à autocrítica elevada, e não a déficits de natureza neurodesenvolvimental.

No heterorrelato, preenchido pelo namorado, os escores situaram-se integralmente na faixa média (T = 50), sem indicadores de prejuízo na comunicação e interação social (T = 50), motivação social (T = 60) ou padrões restritos e repetitivos (T = 54). Essa convergência entre percepções interna e externa reforça a compreensão de que GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA mantém bom repertório de habilidades sociais e empatia, apresentando discreta retração social autopercebida, associada a

características emocionais e de personalidade, e não a comprometimentos próprios de quadros do espectro autista.

De modo geral, o desempenho nas escalas de responsividade social sugere que a paciente demonstra competência interpessoal preservada, empatia elevada e boa leitura de sinais sociais, embora possa se sentir insegura ou sobrecarregada em interações complexas ou em contextos avaliativos, comportamento coerente com o perfil de vulnerabilidade emocional e ansiedade social previamente descrito.

ESAVI-A			
Escala	Pontos	Percentil	Classificação
Falta de concentração e de persistência	50	90	Extremo Superior
Controle cognitivo	26	40	Baixo
Planejamento futuro	20	70	Alto
Audácia e temeridade	16	50	Médio

ESAVI-B			
Escala	Pontos	Percentil	Classificação
Falta de concentração e de persistência	49	90	Extremo Superior
Controle cognitivo	24	30	Baixo
Planejamento futuro	18	60	Médio
Audácia e temeridade	14	50	Médio

Nos resultados obtidos nas formas A e B da ESAVI, observa-se perfil impulsivo com dificuldade significativa de concentração e manutenção de persistência nas tarefas, com desempenho classificado no extremo superior (percentil 90) nessa dimensão. Esse padrão indica tendência à dispersão e à perda de foco diante de múltiplas demandas, o que pode comprometer a execução de atividades cotidianas e acadêmicas que exigem continuidade, organização e controle atencional.

Em ambas as versões, o Controle Cognitivo apresentou escores baixos (percentis 30–40), refletindo propensão a agir de modo precipitado, com dificuldade para planejar respostas ou avaliar adequadamente as consequências de suas ações. Ainda assim, a paciente demonstra nível adequado de prudência no fator Audácia e Temeridade (percentil 50), sugerindo comportamento cauteloso e capacidade de avaliar riscos antes de agir impulsivamente.

O domínio Planejamento Futuro variou entre médio e alto (percentis 60–70), indicando reflexão sobre metas e projeção de ações com base em consequências futuras, ainda que a execução prática dessas intenções possa ser prejudicada por falhas de atenção e descontinuidade comportamental.

De modo geral, o perfil nas escalas de impulsividade descreve uma paciente com funcionamento atencional instável e autorregulação cognitiva reduzida, mas que mantém boa consciência das próprias limitações e prudência em situações potencialmente arriscadas, o que reduz a probabilidade de condutas impulsivas de risco. O padrão é compatível com dificuldades executivas leves e oscilação regulatória emocional, já observadas em outras medidas da avaliação.

A integração dos instrumentos aplicados (BFP, BOLIE, SRS-2 e ESAVI) revela um perfil de personalidade caracterizado por alta sensibilidade emocional, retraimento social e

autocrítica acentuada, associados a elevada empatia, moralidade e abertura a novas experiências. GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA demonstra funcionamento interpessoal preservado, com compreensão emocional e responsividade elevadas, embora apresente dificuldades consistentes de regulação emocional e foco atencional, especialmente em contextos de sobrecarga ou cobrança excessiva.

O BFP apontou neuroticismo muito elevado e extroversão reduzida, com insegurança afetiva, timidez e necessidade de aprovação externa, mas também altos níveis de amabilidade e abertura intelectual, favorecendo o engajamento empático e a reflexão. A BOLIE reforçou essa configuração, evidenciando alta empatia (percentil 87) e baixa regulação emocional (percentil 10), compondo um padrão de hiperresponsividade emocional com pouca autocompaixão e dificuldade de manejo interno das próprias emoções.

As escalas SRS-2 (auto e heterorrelato) indicaram funcionamento social dentro da normalidade, sem indícios de prejuízo em comunicação ou reciprocidade social, confirmando que o retraimento percebido pela própria paciente decorre mais de fatores ansiosos e de autocrítica do que de déficits sociais estruturais. Já a ESAVI evidenciou impulsividade cognitiva e baixa persistência, associadas a prudência e consciência de risco adequadas, reforçando a ideia de oscilações autorregulatórias e dificuldades executivas leves, mas sem comportamento impulsivo de risco.

De modo geral, o conjunto dos achados descreve uma paciente emocionalmente permeável e sensível ao ambiente, que tende a internalizar conflitos e sobrecarregar-se afetivamente, mas que também dispõe de empatia, consciência e abertura à mudança — recursos que favorecem o desenvolvimento pessoal e o manejo clínico positivo quando apoiada por um contexto terapêutico de acolhimento e estrutura.

4.3. Observações Comportamentais

Durante o processo avaliativo, GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA apresentou-se pontual, colaborativa e participativa, mantendo boa compreensão das instruções e agilidade na execução das tarefas. Demonstrou atenção adequada, raciocínio rápido e comunicação clara, com vocabulário amplo e coerente.

O humor manteve-se levemente rebaixado, sem impacto no desempenho ou engajamento. A paciente mostrou-se motivada, concentrada e disposta, cumprindo as atividades com autonomia e constância. O comportamento afetivo e motor foi estável e adequado, favorecendo interação empática e vínculo clínico positivo ao longo de todo o processo avaliativo.

5. Conclusão

Com base na integração entre dados objetivos, observações clínicas e critérios do DSM-5-TR, os achados são compatíveis com Transtorno Depressivo Maior, episódio atual, com especificador de gravidade grave (F33.2), associado a sintomas ansiosos de intensidade moderada a grave, compatíveis com Transtorno de Ansiedade Generalizada (F41.1).

O conjunto de evidências indica que o sofrimento afetivo exerce impacto direto sobre a atenção, a organização e a autorregulação, resultando em oscilações funcionais

secundárias ao estado emocional, mas sem preencher critérios diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH).

Considera-se, portanto, que o quadro atual reflete comprometimento afetivo-ansioso de natureza episódica, com potencial de remissão mediante acompanhamento terapêutico e farmacológico adequados, e preservação dos recursos cognitivos e da capacidade crítica.

Recomendações de intervenção e monitoramento

- Psicoterapia individual em abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), com foco em reestruturação cognitiva, treinamento de autorregulação emocional e estratégias de gerenciamento do tempo e prioridades;
- Acompanhamento psiquiátrico contínuo, visando ajuste e monitoramento farmacológico, especialmente frente à presença de sintomas depressivos e ansiosos de intensidade clínica;
- Estímulo à manutenção de rotinas estruturadas, com estabelecimento de metas graduais e realistas, priorizando o equilíbrio entre demandas pessoais, acadêmicas e profissionais;
- Treinamento de habilidades sociais e assertividade, favorecendo autoconfiança, comunicação clara e limites interpessoais saudáveis;
- Práticas de autocuidado e atividades de relaxamento ou lazer, como exercícios físicos, meditação ou leitura, com o objetivo de reduzir o nível de tensão e promover bem-estar emocional;
- Reavaliação neuropsicológica após período mínimo de 12 meses, ou antes, caso ocorram mudanças significativas no quadro clínico ou no funcionamento cotidiano.

Ressalva Clínica

Ressalta-se que o ser humano possui uma natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada. Os resultados aqui expostos dizem respeito ao funcionamento das funções cognitivas, personalidade, humor e afetividade de GABRIELLY DOS SANTOS ROCHA no momento presente, podendo haver alterações posteriores, dependendo das contingências ambientais vivenciadas e/ou dos acompanhamentos recebidos.

6. Referências

American Psychiatric Association. (2022). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5-TR (5ª ed., texto revisado). Porto Alegre, RS: Artmed.

Barbosa, I. G., & colaboradores. (2015). SRS-2: Escala de Responsividade Social-2 [Manual]. São Paulo, SP: Casapsi Livraria e Editora Ltda.

Barkley, R. A. (2012). BDEFS: Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley. São Paulo, SP: Hogrefe CETEPP – Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.

Derogatis, L. R. (2019). BSI: Inventário Breve de Sintomas. São Paulo, SP: Pearson Clinical Brasil.

Gonçalves, A. P., & Raven, J. (2021). EAG-A: Escala de Ansiedade Generalizada – Versão Adulto (Manual). Vetor Editora.

Marín Rueda, F. J. (2022). BPA-2: Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção 2. São Paulo, SP: Vetor Editora.

Miguel, F. K. (2021). BOLIE: Bateria Online de Inteligência Emocional: Manual técnico. Vetor Editora.

Mizuta, G. A. A., & Carvalho, L. F. (2022). BHS: Escala de Desesperança de Beck. São Paulo, SP: Casapsi Livraria e Editora Ltda.

Mizuta, G. A. A., & Carvalho, L. F. (2022). EPF-TDAH: Escala de Prejuízos Funcionais no TDAH. São Paulo, SP: Casapsi Livraria e Editora Ltda.

Mônego, B. G., Trentini, C. M., Argimon, I. I. L., Silva Filho, J. H., Barboza, L. L., Rigoni, M. S., & Oliveira, M. S. (2018). Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST). São Paulo, SP: Hogrefe CETEPP – Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.

Nunes, C. H. S. S., Hutz, C. S., & Nunes, M. F. O. (2009). Bateria Fatorial de Personalidade (BFP). São Paulo, SP: Casapsi Livraria e Editora Ltda.

Paula, J. J. de, Malloy, L. F., & Sedó, M. (2015). Teste dos Cinco Dígitos (FDT). São Paulo, SP: Hogrefe CETEPP – Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.

Rey, A., Paula, J. J. de, & Malloy-Diniz, L. F. (2018). Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT). São Paulo, SP: Vetor Editora.

Rueda, F. J. M., & Ávila-Batista, A. C. (2013). EsAvl-A e EsAvl-B: Escala de Avaliação da Impulsividade: Manual técnico. Vetor Editora.

Serpa, A. L. de O., Timóteo, A. P. P., Silva, R. de O., Querino, E. H. G., & Malloy-Diniz, L. F. (2023). TOL-BR: Torre de Londres: Manual técnico. Vetor Editora.

Serpa, A. L. O., Schlottfeldt, C. G. M. F., & Malloy-Diniz, L. F. (2019). Teste d2-R: Revisado. São Paulo, SP: Hogrefe CETEPP – Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.

Trentini, C. M., Yates, D. B., & Heck, V. S. (2011). Escala de Inteligência Wechsler Abreviada (WASI). São Paulo, SP: Casapsi Livraria e Editora Ltda.

Werlang, B. S. G., Gorenstein, C., Argimon, I. I. L., & Wang, Y.-P. (2010). BDI-II: Inventário de Depressão de Beck (versão brasileira). São Paulo, SP: Casapsi Livraria e Editora Ltda.

Petrolina, 23 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **HELEN TAIZY LIRA DE MENDONÇA**
Data: 23/11/2025 17:56:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helen Taizy Lira de Mendonça
Pós-graduada em Neuropsicologia
Psicóloga – CRP 02/28219